Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 15ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F:( )

Processo nº **0157551-06.2023.8.17.2001**

AUTOR(A): M. F. P. G.
REPRESENTANTE: KATIA MARIA DE FRANCA PAIVA, MARCELO PAIVA GOMES

RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

SENTENÇA

Vistos, etc…

MARCELE FRANCA PAIVA GOMES, menor púbere, representada nesta ação por seus genitores, todos qualificados, por meio de seu advogado legalmente constituído, propôs, quando viva, a presente **AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA**, em face da **CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI**, alegando resumidamente que (id. 155260536) que:

1- A parte autora é beneficiária de plano de saúde coletivo administrado pela requerida, de cobertura nacional, cartão nº 0300067700450658 (Doc. 02), negócio precipuamente constituído para preservação e promoção da saúde.
2- Desde o início da vigência do respectivo plano contratado (05/07/2007), em nenhum momento deixaram os pais da menor de cumprir com a sua parte na avença, pagando as parcelas nas respectivas datas de vencimento, com desconto direto em folha.
3- Há prova consistente nos autos de que a autora foi diagnosticada com transtorno global do desenvolvimento, associado ao transtorno de personalidade com instabilidade emocional (autismo atípico) e à síndrome de fibromialgia (Doc. 04), e que, devido à falta de resposta terapêutica dos tratamentos realizados, houve indicação de exame consistente no teste farmacogenético para melhor escolha do tratamento.
4. Para o psiquiatra que acompanha a requerente, Dr. Pedro Ulisses Monteiro Carreiro (CRM 26665 PE), a paciente apresenta: "(...) sintomas de apatia, pensamentos intrusivos, negativos e autodepreciativos; insônia inicial e intermediária; choro; ideação suicida; instabilidade emocional, impulsos autolesivos. Queixa-se também de quadro de dor difusa associado ao diagnóstico de fibromialgia" (sic), motivo pelo qual faz uso controlado de medicamentos.
5- Contudo, diante da falta de meios efetivos para controle dos transtornos que acometem a autora, foi proposta pelo médico assistente a realização de um teste farmacogenético do sistema nervoso central (Doc. 05), visando descobrir quais as medicações mais adequadas para o tratamento da paciente, tendo ocorrido negativa de custeio pela requerida (Doc. 06), sob justificativa de ausência de tal procedimento no ROL de coberturas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
6. Em momento algum a ré demonstra existir no rol da ANS alternativa igualmente eficaz, limitando-se a negar a cobertura do procedimento de forma genérica.
7. Conforme asseverado em laudo, o teste referido pode modificar a história natural do tratamento da paciente de maneira favorável, ou, em caso de não o realizar, ter impacto negativo na evolução da enfermidade, já que demonstra resistência terapêutica aos diversos ensaios farmacológicos instituídos.

8. Para o Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la.
9. Em consequência, firmou-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tipo de exame ou tratamento por este indicado, tal como ocorreu no presente caso.
10. Assim sendo, em que pese às alegações lançadas pela ré, destaca-se o real perigo de dano a requerente na hipótese de atraso na realização do respectivo procedimento, já que os atuais medicamentos prescritos a paciente não impedem os episódios de automutilação, agressividade e descontrole do seu próprio corpo.
11. À luz deste apanhado, conclui-se, sem maiores dificuldades, que a manutenção da recusa do teste farmacogenético do sistema nervoso central, representa, ao fim ao cabo, a irreversibilidade do quadro da paciente e piora da sua condição de saúde.

Pelo exposto, requereu: (a) a concessão de tutela provisória de urgência antecipada para que a ré autorizar e custear de imediato as despesas para a realização do teste farmacogenético do sistema nervoso central; (b) a confirmação da tutela em sentença; (c) reparação por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Despacho deixando para apreciar a tutela após a manifestação da parte ré (id. 155614914).
Manifestação da demandada (petição de id. 157314477).
Resposta da autora (id. 159174218).

Na decisão de id. nº 159354393, este Juízo concedeu a liminar, vejamos o dispositivo da decisão:

> EM FACE DO EXPOSTO E FUNDAMENTADO, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, DE ACORDO COM ARTIGO 300, DO CPC, PELO QUE DETERMINO QUE SEJA INTIMADA A DEMANDADA, A FIM DE QUE, NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DA INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, AUTORIZE O TESTE FARMACOGENÉTICO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM FAVOR DA AUTORA, MARCELE FRANCA PAIVA GOMES, CPF 110.313.504-03, SOB PENA DE BLOQUEIO DO IMPORTE FINANCEIRO REFERENTE AO CUSTO DO TRATAMENTO, POR MEIO DA FERRAMENTA SISBAJUD, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONFORME ARTIGO 497 DO CPC.

Devidamente citada, a demandada apresentou sua contestação, onde sucita (petição de id. 160664596):

a) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA:

> 1. Em sua petição inicial a autora não demonstra que o procedimento, para seu quadro clínico, detém respaldo científico. não preenchendo os requisitos exigidos na lei 14.454/2022 para cobertura excepcional à taxatividade do Rol.
> 2. Pois bem, é de fácil verificação que o pedido objeto da presente ação é a condenação da CASSI na cobertura de procedimento e/ou evento não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, com fundamento na recém editada Lei n.º 14.454/2022 (que alterou a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames que não estão incluídos no rol).
> 3. A lei em questão prevê que a cobertura não prevista no Rol deverá ser autorizada pela operadora de plano de saúde, desde que: (i) exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; (ii) existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único

de Saúde (Conitec); ou (iii) exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

4. Não há nos autos a comprovação documental de que o procedimento e/ou evento em saúde prescrito pelo médico assistente seria eficaz, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; da existência de recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC); ou mesmo parecer de avaliação de tecnologias em saúde realizada por órgão com comprovado renome internacional e desde que sejam aprovadas também para seus nacionais, devidamente traduzida, nos termos do parágrafo único do art. 192 do Diploma Processual Civil.

5. A nova redação dada ao §13, do art. 10, da Lei 9.656/98, não deixa dúvidas de que a prescrição do médico assistente não é suficiente, por si só, para que a cobertura não prevista no Rol de procedimentos e eventos em saúde seja autorizada pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde.

6. Em virtude do exposto, requer que a autora seja intimada para que, no prazo de 15 dias, apresente a documentação necessária, sob pena de indeferimento da petição inicial, com a extinção do feito sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC.

b) IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, requerendo a revogação dos beneplácitos da gratuidade de justiça, eis que a Autora não traz aos autos qualquer documento que comprove que o pagamento de custas e/ou honorários advocatícios lhe colocaria em condição de miserabilidade, nem tampouco colocariam em risco o seu próprio sustento e/ou de sua família.

c) NO MÉRITO, alega, resumidamente, que:

1. Antes de adentrar ao mérito, entende-se, ser necessário esclarecer que esta Associação possui modalidade de autogestão em saúde, sendo certo que o tratamento jurídico nas relações entre os associados e o plano de saúde, deve obedecer a algumas diretrizes.

2. Pois bem, a CASSI é classificada pela ANS como autogestão, sendo impedida de comercializar planos individuais e familiares, restrita apenas a planos de natureza coletiva ou empresarial.

3. Ocorre que o STJ firmou o entendimento acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos firmados entre os usuários e as entidades de autogestão, nos termos do entendimento sumulado abaixo destacado: Súmula 608-STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a CASSI, no caso. Destarte, a CASSI manifesta oposição ao uso dos dispositivos da Lei 8.078/90 (CDC) enquanto fonte do direito no caso concreto.

4. Logo, o Julgador deverá se ater à Lei 9.656/98, ao Código Civil, ao Estatuto Social da CASSI, às normas regulamentares e ao contrato firmado entre as partes, evidenciando a inexistência de fundamentos jurídicos que amparem a pretensão autoral.

5. Pois bem, estando esclarecida a natureza jurídica da CASSI auto-gestão, calha informar que para que haja uma relação contratual, é necessário que se pondere alguns requisitos para a formação de um contrato, a saber, (a) autonomia da vontade e o consensualismo,

que representarão o aceite das partes no que lhes foram ofertados; (b) a capacidade das partes, ou seja, a possibilidade de exprimir vontade no mundo jurídico; e (c) o objeto, que deverá ser lícito, possível e determinado.

6. Sendo assim, o desrespeito pela CASSI das normas e condições previamente fixadas, concernente aos seus Planos de Saúde, certamente impedirá a continuidade da empresa, face à sua inviabilidade administrativa e financeira, decorrente de eventual desrespeito aos limites das coberturas previamente fixados.

7. A Lei nº. 9.961/2000 deixou claro que compete à ANS a elaboração do rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os planos de saúde.

8. Em complemento, a mesma Lei definiu que compete à Diretoria Colegiada da ANS editar normas sobre matérias de competências da ANS, tal qual a elaboração do rol de procedimentos.

9. Igualmente, a Lei nº 9.656/98 estatuiu no §4º, do artigo 10, que a amplitude das coberturas será definida por normas editadas pela ANS.

10. Já a Resolução Normativa 465/2021 da ANS dispõe sobre a taxatividade do rol.

11. Compulsando o Anexo I da RN 465 da ANS, não identificamos a realização do teste de farmacogenético do sistema nervoso central entre os eventos com cobertura obrigatória, existindo outros tratamentos disponíveis no ROL a serem utilizados pelo médico assistente da Autora.

12. Permissa vênia, ilustre julgador, a autora vem requerer tratamento diverso não contemplado em contrato, afrontando, cabalmente, a cláusula do instrumento contratual. Quanto ao contrato, a TGA consiste no documento que dispõe os procedimentos cobertos pelo plano.

13. Ainda, o contrato faz clara referência ao atendimento conforme guia o Rol da coberturas obrigatórias da ANS.

14. Portanto, os eventos fora da Tabela Geral de Auxílios não possuem cobertura contratual.

15. Vale dizer, todos os contratos, também chamados de condições gerais, da operadora de saúde foram devidamente protocolados junto a ANS, prevendo todos os requisitos exigidos pela agência.

16. Já a legislação específica aplicada a saúde suplementar, lei 9.656/98, prever a restrição de cobertura a eventos não contemplados no ROL.

17. Logo, procedimento não contemplados no ROL da ANS não recebem cobertura respaldo e/ou guarida do contrato.

18. Recentemente, em meados de março de 2022, foi promulgada a lei 14.307 que altera a lei 9656/98 sobre o processo de atualização das coberturas no âmbito da saúde suplementar.

19. É de fácil verificação que o pedido objeto da presente ação é a condenação da CASSI na cobertura de procedimento e/ou evento não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, com fundamento na recém editada Lei n.º 14.454/2022 (que alterou a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames que não estão incluídos no rol).

20. A lei em questão prevê que a cobertura não prevista no Rol deverá ser autorizada pela operadora de plano de saúde, desde que: (i) exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; (ii) existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); ou (iii) exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

21. Dito isto, o evento não recebe cobertura no ROL da ANS.

22. O teste farmacogenético do sistema nervoso central foi submetido à ANS para incorporação, sendo objeto de discussão pela agência, sendo negado expressamente à incorporação ao Rol.

23. Por fim, DD Julgador, denota-se do laudo médico acostado que não há demonstração de que o quadro da autora se enquadre nas exceções descritas na Lei.

Pelo que, requer a revogação da gratuidade de justiça, o acolhimento da preliminar e, caso não acolhida, a improcedência da demanda.

Petição da ré informando o cumprimento da tutela (id. 160665936).
Audiência de conciliação sem acordo (id. 166561669).
Réplica de id. 170025358.
Despacho de provas (id. 173108126), sem qualquer pedido de dilação probatória.

ISSO POSTO, PASSO A DECIDIR:

1. DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE:

De logo, faço constar que a Constituição Federal prescreve em seu artigo 1º, inciso III que:

> Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
> (...)
> III - a dignidade da pessoa humana.
> (...)

Especificamente em seu artigo 5º, que trata dos direitos e garantias individuais, a CF/88 prescreve a inviolabilidade do direito à vida.
Ora, o direito à vida é sem dúvida alguma o mais importante de todos os valores, pois dele emana a eficácia de todos os demais, *v.g.*, saúde, moradia.
Desta feita, é de absoluta prioridade para o Estado preservar a vida dos indivíduos, prestando todo o auxílio necessário para que, com esse direito assegurado, o cidadão possa exercer todo o feixe de direitos fundamentais que dele emanam.
Por sua vez, o artigo 196 da Carta Política traz - expressamente - que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, ao prescrever que:

> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Todavia, embora seja dever do Estado a assistência à saúde, esse serviço é de livre iniciativa privada, consoante artigo 199 da CRFB/88:

> Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Verifica-se, pela leitura dos artigos supracitados, que a iniciativa privada pode promover à assistência à saúde, entretanto,tem que ter em mente que "cuida" do mais importantes de todos os valores garantidos ao cidadão, qual seja: a vida, pois é da vida que emanam todos os direitos fundamentais.
Por isso, o plano de saúde privado deve respeitar todas as normas constitucionais que versem sobre a garantia da saúde dos pacientes, evidentemente, daquele grupo fechado beneficiário do serviço, como no caso dos clientes da demandada deste processo.

Dessa forma, deve às normas contratuais estipuladas entre o particular, prestador do serviço de saúde e os contratantes serem regidas pelas normas supra.

2. DA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES:

Em relação ao tema trazido neste item, destaco que há nos Tribunais Pátrios um verdadeiro inconformismo quanto à inaplicabilidade do CDC nas relações entre segurados e planos de saúde de autogestão.
Sobre o tema em questão, posiciono-me favorável a aplicabilidade do CDC e lamento, data a máxima vênia, a tese que saiu vencedora junto a Corte Superior.
Todavia, mesmo lamentando, sou obrigado a me curvar ao dito entendimento, uma vez que a Segunda Seção (Direito Privado - que está vinculado a 3ª a 4ª Turma) pacificou a divergência entre as turmas com a definição da inaplicabilidade do CDC, senão vejamos:

> RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração,

forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. 4. Recurso especial não provido.
(REsp 1.285.483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 16/8/2016).

Pelo que, em que pese discorde frontalmente dessa inaplicabilidade do CDC, sou obrigado a adotá-la, motivo pelo qual no julgamento da demanda não será aplicada a legislação consumerista.

3. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA:

Deixo de apreciar a impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que, embora a parte autora tenha requerido a gratuidade na petição inicial, este Juízo requereu, antes de apreciar o pedido de gratuidade, que fosse apresentado documentos comprobatórios.
Entretanto, quando intimada para apresentar documentos que comprovassem a necessidade da concessão, a parte autora realizou o pagamento das custas processuais iniciais, tendo o pedido de gratuidade perdido seu objeto.

Pelo que, tendo em vista que não houve concessão da gratuidade de justiça e que a autora realizou o recolhimento das custas processuais iniciais, antes mesmo da contestação do processo, não acolho a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o pedido perdeu seu objeto com o recolhimento, pela autora, das custas iniciais.

4. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA:

Alega a parte ré que a parte autora não apresentou os documentos essenciais para a propositura da demanda, pois não foi anexado as provas que demonstram que está preenchido as condições excepcionais, exigidas pela Lei, para que se defira o exame prescrito pelo médico que está fora do rol da ANS.

Pois bem, é fácil perceber que a ausência de prova das "condições especiais previstas em Lei" para que se defira, excepcionalmente, o exame fora do rol da ANS, não se enquadram como documentos essenciais para a propositura da demanda que levariam o feito a ser extinto sem julgamento do mérito.

Ora, tais documento, caso realmente necessários e não sendo apresentados, enquadram-se como questões de mérito que levariam ao julgamento de improcedência da demanda, de forma que não há o que se falar em extinção do feito sem julgamento do mérito.

Pelo que, com base nesses fatos, não acolho a preliminar suscitada na defesa da demandada.

5. DOS FATOS INCONTROVERSOS:

Faz-se necessário elucidar que o Digesto Processual Civil prescreve em seu artigo 36, que cabe (...) *ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir*.
Ademais, prescreve ainda o artigo 341 que *Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas* (...).

Ora, analisando a tese de defesa, verifico que a demandado não se contrapõe aos seguintes fatos narrados na inicial, sendo desnecessária, por conseguinte, a produção de provas, pela presunção de veracidade dos fatos: (a) a qualidade de segurada da parte autora e a ausência de mensalidades em aberto; (b) que a autora foi diagnosticada com com transtorno global do desenvolvimento, associado ao transtorno de personalidade com instabilidade emocional (autismo atípico) e à síndrome de fibromialgia; (c) que o médico que acompanha o paciente prescreveu o exame consistente no teste farmacogenético para melhor escolha do tratamento; e (d) que o procedimento foi negado pela ré por estar fora do rol da ANS.
Desta feita, verifica-se que os fatos supracitados são tidos por incontroversos, sendo desnecessária a prova de sua veracidade.

Cumpre esclarecer que a tese da defesa, quanto ao mérito da demanda, é formulada na tentativa - em resumo - de justificar a legitimidade do plano de saúde em negar o custeio do procedimento, sob as seguintes alegações: (a) o exame não está previsto no rol da ANS; (b) não há previsão contratual de cobertura; e que (c) não foi comprovado pela autora as condições especiais, previstas na Lei, para que o plano seja obrigado a custear, excepcionalmente, o tratamento que não está previsto no Rol da ANS.
Conclui-se, portanto, que a demandada não nega a utilidade e necessidade do tratamento, pois sustenta sua negativa com base em falta de previsão Legal e contratual.

Ex positis, é unicamente sobre os pontos da defesa (controversos nos autos) que este Juízo passa a enfrentar, uma vez que os pontos incontroversos supramencionados são presumidamente verdadeiros, dentre eles a doença que acomete a autora e a necessidade e utilidade do procedimento, utilidade e necessidade essa que foi, inclusive, admitida pela ré em sua contestação que se resume a negar a cobertura por falta de previsão legal e contratual.

6. DA (I)LEGALIDADE DE NEGATIVA:

Quanto à necessidade do teste farmacogenético - perfil sistema nervoso central, faço destacar que há no processo laudo médico que demonstra cabalmente que o médico assistente requereu expressamente o exame; neste laudo ele esclarece a necessidade do procedimento, face à falta de resposta efetiva ao tratamento pela paciente (id. 155261989), vejamos o teor da manifestação do médico assistente:

> Atesto para os devidos fins, que a paciente acima citada, está em acompanhamento há cerca de 8 meses para quadro de CID: 10: F84.1 e F60.3; M79.7, apresentando sintomas de apatia, pensamentos intrusivos, negativos e autodepreciativos; insônia inicial e intermediária; choro; ideação suicida; instabilidade emocional, impulsos auto lesivos. Queixa-se também de quadro de dor difusa associado a diagnóstico de fibromialgia. Atualmente em uso de Carbolitium 450mg (1+0+1), Duloxetina 60mg (1+0+0); Rivotril 0,25mg 1 cp SL S/N; Amitriptilna 25mg (0+0+1); Fenergam 25mg (0+0+1); Clonazepam 2mg (0+0+1); porém com resposta ainda em caráter parcial ao tratamento, apresentando episódios frequentes de reagudização dos sintomas ansiosos apesar de otimização das medicações. Levando em consideração refratariedade do caso, solicito realização de **teste farmacogenético** para auxílio uma resposta terapêutica mais efetiva e controle dos sintomas do quadro médico.

Ou seja, o exame em questão de fato foi prescrito pelo médico que acompanha a paciente.
Ademais, resta comprovado que a paciente, ora demandante, tem, inclusive, ideação suicida (vindo a atentar efetivamente contra a sua vida no curso do processo) e que o teste farmacogenético pode vir a melhorar/auxiliar uma resposta terapêutica mais efetiva e controlar os sintomas do quadro médico
Desta feita, resta suficientemente comprovado a necessidade urgente - **no caso concreto** - da realização do teste autorizada pela Decisão Provisória de Urgência, pois o médico responsável, além de ter requerido o procedimento justifica a sua perene necessidade para salvaguardar a vida da requerente, pois atesta o risco de morte da autora que tem ideação suicida.
Feitas essas ponderações, passo a enfrentar a tese trazida pela defesa que sustenta que a negativa de custeio do tratamento se deu de forma devida.

Dentro deste cenário, faço destacar que a Jurisprudência pátria é uníssona ao se posicionar pela abusividade da negativa do plano de saúde em não autorizar a realização de tratamentos prescritos pelos médicos responsáveis, uma vez que, sendo a especialidade coberta pelo plano em questão, cabe ao profissional habilitado promover o cuidado do paciente, requerendo os procedimentos necessários.
Desta feita, não cabe ao plano de saúde avaliar as prescrições médicas, fazendo juízo de valor do que deve ou não ser autorizado, ou seja: o contrato de seguro saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para cada uma delas.
No caso em comento, deve ser observado os princípios da boa-fé e da confiança, sendo vedado à seguradora perceber por anos a contribuição da segurada para se esquivar da cobertura do tratamento/exame indispensável ao tratamento da paciente, justamente quando do surgimento da doença.
O Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco se filia ao posicionamento aqui esposado reiteradamente quanto à abusividade da negativa de autorização de procedimentos, vejamos julgados recente a respeito do tema:

> PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO E MEDICAMENTOS INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1- Procedimento solicitado por profissional médico como medida imprescindível ao tratamento da saúde do segurado. 2- Não pode ser negada cobertura a tratamento e medicamentos pelo simples fato de não constarem no guia da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, uma vez tenham sido prescritos pelo médico assistente e a enfermidade a ser tratada esteja prevista no contrato firmado entre as partes. 3- Cabível a indenização por danos morais em decorrência do agravamento do abalo psicológico em que se encontra o paciente, estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4- Montante fixado a título de danos extrapatrimoniais em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
> (TJ-PE - AGV: 3127691 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/09/2013, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2013)

> TJ-PE - Apelação APL 3701862 PE (TJ-PE) (http://tj-pe.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18393apl-3701862-pe) Data de publicação: 27/04/2015 Ementa: Apelação Cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura de exame de Tomografia de Coerência Ótica - OCT. Danos morais configurados. Manutenção do valor indenizatório. Negado provimento ao recurso. Decisão unânime. I - Pode o contrato de seguro saúde limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para cada uma delas. II - A medicina em constante evolução, razão pela qual novas tecnologias relacionadas a exames e procedimentos médicos surgem a todo momento. Deste modo, não se pode falar em ausência de cobertura contratual de determinados exames que provavelmente nem existiam à época da contratação do plano de saúde em questão. IV - Nos contratos de plano de saúde devem incidir os princípios da boa-fé, da confiança, da hipossuficiência e da vulnerabilidade não sendo legítimo à seguradora perceber por anos a contribuição do segurado para se esquivar da cobertura do tratamento indispensável à permanência da vida dele justamente quando do surgimento da doença. V - A conduta da operadora em negar custeio ao medicamento necessitado pela paciente frustrou a legítima expectativa de ser protegida no momento de infortúnio. Nessa ocasião, o dano é claro e presumido, considerando-se o abalo à moral da vítima, pois teve o estado de tensão psicológica e de angústia intensificados pelo tratamento recusado.VI - Valor indenizatório mantido em R$8.000,00, pois chega a ser inferior aos parâmetros adotados pelo STJ e por esta Corte em casos análogos.VII - Recurso não provido por unanimidade

> CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HEMODIÁLISE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PLANO DE SAÚDE NÃO PODE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO. DEVER DA OPERADORA DE SAÚDE EM CUSTEAR O TRATAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MANIFESTA

IMPROCEDÊNCIA DO APELO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE ENSEJAR A REVISÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂMIME.
(TJ-PE - AGV: 4156727 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 22/12/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2016)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA E MATERIAL INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. IMPLANTE DO SISTEMA ANGEL/MED GUARDIAN. APLICA-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS ENVOLVENDO OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE QUE ATUAM NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO É POSSÍVEL À OPERADORA LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS. CABE AO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE A ESCOLHA. DECISÃO TÉCNICA. PRECEDENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. MANTIDA A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. AGRAVO LEGAL NÃO PROVIDO.
(TJ-PE - AGV: 3991422 PE, Relator: Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, Data de Julgamento: 15/12/2015, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/01/2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CDC. RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO. NA ORIGEM: AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLOCAÇÃO "UTEROSCÓPICA DE DUPLO J". EXCLUSÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. CIRURGIA REQUERIDA SEGUNDO DIAGNÓSTICO DO PROFISSIONAL COMPETENTE. DEVER DA OPERADORA DE SAÚDE EM CUSTEAR O TRATAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO APELO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE ENSEJAR A REVISÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂMIME.
(TJ-PE - AGV: 4034788 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 20/10/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2015)

De mais a mais, mesmo o teste farmacogenético não estando previsto no Rol de procedimentos obrigatórios da ANS, isso não justifica a sua negativa quando o médico assistente atesta a sua necessidade, pois há muito tempo a jurisprudência já definiu que o rol supracitado nada mais é que um rol de coberturas mínimas, senão vejamos julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:

Apelação Cível. Plano de saúde. Tratamento de radioterapia com técnica de modulação de intensidade no feixe. Negativa de cobertura. Abusividade. Incidência da legislação consumerista. Rol de procedimentos elencados pela ANS que serve apenas como referência para cobertura assistencial mínima. Dever de cobertura. Recurso não provido por unanimidade.
I **- Pode o contrato de seguro saúde limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para cada uma delas.**
II - **Se o plano possui cobertura para a especialidade de oncologia e o tratamento mais eficiente a ser ministrado ao paciente nesse caso, segundo entendimento médico consiste radioterapia com técnica de modulação de intensidade no feixe não há razão para excluir o referido procedimento da cobertura securitária, sob pena de se negar ao beneficiário o tratamento adequado à sua enfermidade e, por consequência, ferir a própria finalidade do contrato firmado entre as partes.**
III - No caso, o médico assistente do segurado justificou a necessidade do tratamento em questão por ser a única opção terapêutica com finalidade curativa e ainda destacou a necessidade de urgência da autorização de cobertura devido à velocidade de aumento do tumor.
IV - O Rol da ANS não é taxativo, contendo apenas a referência para a cobertura assistencial mínima obrigatória dos planos de saúde.
V - A previsão dos riscos segurados e as limitações de cobertura no contrato de seguro não consistem, por si só, em ilegalidade. No entanto, a possibilidade de predeterminar os riscos cobertos não justifica a estipulação de cláusulas abusivas e contrárias às disposições do CDC.VII - Recurso apelatório não provido por unanimidade.

(Processo APL 3850531 PE Orgão Julgador 3ª Câmara Cível Publicação 14/01/2016 Julgamento 17 de Dezembro de 2015 Relator Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto)

Quanto a este tema (taxatividade ou não do rol), destaco que tempos atrás existiu uma séria insegurança jurídica, pois a divergência entre a 3ª e 4ª Turmas do STJ afetou tal tema para análise.
Antes de a Corte definir sobre a taxatividade ou não do rol foi publicada nova Lei reforçando a taxatividade do rol, situação que levou o STJ (2ª Seção) a definir pela taxatividade rol, entretanto com algumas exceções, chegando-se a conclusão que a tese adotada foi a da taxatividade mitigada.
Entretanto, em 21/09/2022, foi sancionada nova Lei de nº 14.454/2022, que altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e trata dos planos privados de assistência à saúde.
Nesta nova Lei as operadoras de planos de saúde estão obrigadas a financiar tratamentos que não estiverem na lista mantida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Desta feita, a discussão sobre a natureza exemplificativa ou taxativa do rol fora sepultada com a nova Lei 14.454/2022 que previu expressamente que tal rol é um rol de cobertura mínima.
Por conseguinte prevendo a Lei a exemplificatividade do rol, não cabe a este Juízo acolher a defesa, de forma que se mostra ilegal a negativa de cobertura da técnica com base na ausência de sua previsão no rol, pois a Lei que trata dos planos de saúde, como já esclarecido nesta sentença, prevê claramente que o rol é exemplificativo.

Vê-se portanto, à luz da jurisprudência supracitada, que o contrato do plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para cada uma delas, pois a indicação do tratamento devido cabe ao médico do paciente.
Pela jurisprudência supra se infere também que o rol de coberturas obrigatórias da ANS é um rol mínimo, prevalecendo a indicação do médico assistente, pois cabe ao médico analisar o caso da paciente e adotar o procedimento mais adequado, com a finalidade de preservar a sua vida.
Desta feita, eventual alegação de que o contrato não cobre aquele procedimento ou que ele não consta no rol de coberturas obrigatórias da ANS não pode prosperar.

De mais a mais, está cabalmente demonstrada nos autos a necessidade do teste farmacogenético; somado a isso, a ré não prova nos autos a desnecessidade do tratamento, nem indica outro tratamento/exame que atingiria o mesmo fim almejado e nem mesmo comprova que a prescrição não atingiria ao fim almejado.

Atesto, ainda, que em demandas idênticas, os Tribunais Pátrios vem acolhendo as pretensões dos pacientes, vejamos julgados:

> PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME. **Autor que ajuizou a presente demanda visando compelir a ré a oferecer cobertura para exame farmacogenetico do sistema nervoso central, do qual necessita**. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. **Recusa de cobertura do exame médico que não encontra respaldo. Ato ilícito. Disposição contratual de exclusão do tratamento indicado pelo médico para diagnóstico e tratamento de doença coberta vai de encontro com os objetivos inerentes à própria natureza do contrato**. Violação art. 51, IV e §1º, CDC, e art. 424, CC. Inteligência das Súmulas n. 96 e 102 do TJSP. Precedentes. Cobertura devida. Sentença alterada. Recurso provido.
> (TJSP; Apelação Cível 1014197-21.2020.8.26.0008; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2021; Data de Registro: 28/06/2021)

> AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. **PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE. RECUSA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO**. I - O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. II - **O**

> **Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.** III - Na demanda, **foi prescrito exame farmacogenético à autora, portadora de transtorno depressivo grave com ideação suicida, para melhor manejo farmacológico do seu quadro clínico, em razão da baixa resposta aos medicamentos já utilizados. IV - A recusa de cobertura pela Seguradora-ré foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato**. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. V - A negativa de cobertura gerou ansiedade, angústia e estresse à autora, aptos a caracterizar o dano moral. VI - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. VII - Apelação desprovida.
> (TJDFT. 07397101620208070001 - (0739710-16.2020.8.07.0001 - Res. 65 CNJ). Relatora: VERA ANDRIGHI. 6ª Turma Cível. Julg.: 23/06/2021).

> OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Sentença de procedência, condenando a operadora de saúde ao custeio do teste farmacogenético do sistema nervoso central e indenização por danos morais. Inconformismo da requerida que pretende a improcedência da demanda. Inconformismo da autora que pretende a majoração da indenização por danos morais. **Negativa de cobertura do plano de saúde, afirmando ausência de previsão contratual. Não cabe às operadoras de plano de saúde questionar, impugnar ou condicionar os procedimentos, exames, medicamentos e tratamentos indicados pelo médico que acompanha o paciente. Prevalência do direito à saúde. Inteligência das Súmulas nº 96 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes.** (...).
> (TJSP; Apelação Cível 1005278-35.2018.8.26.0292; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro: 01/08/2019)

Desta feita, à luz desta fundamentação, outra solução não há que não seja julgar procedente o pedido autoral com a condenação da ré para que ela autorize e custeie o teste farmacogenético, conforme prescrição médica, tornando definitiva a tutela provisória de urgência concedida na decisão de id. 159354393.

7. DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS:

A respeito do pleito indenizatório de danos morais, constato que a requerente sustenta que a negativa do TESTE FARMACOGENÉTICO, indicado pelo médico assistente, gerou danos morais indenizáveis.
É importante realçar que não se faz necessário analisar se houve falha na prestação do serviço, uma vez que neste manto sentencial já foi constatada a referida falha da demandada que não promoveu as autorizações e custeio do exame quando deveria fazê-lo.
Ressalte-se que a responsabilidade da demandada é objetiva, ou seja, independente de culpa, à luz do artigo 927, p.u., do CC/02, vejamos a norma:

> Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
> Parágrafo único. **Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa**, nos casos especificados em lei, ou **quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem**.

Pelo que basta neste momento analisar se a falha na prestação do serviço gera dano moral a ser reparado e promover a definição *quantum* indenizatório.
Ou seja, faz-se necessário observar se os elementos da responsabilidade objetiva (ação/omissão, nexo causal e dano) são verificados no caso concreto.

O elemento (a) omissão está configurado, uma vez que a ré deixou de autorizar o teste farmacogenético, quando era seu dever fazê-lo, o que pôs em risco a saúde da segurada.

O (b) nexo de causalidade também está demonstrado no caso concreto, pois em sendo reconhecido que a negativa de tratamento gera dano moral indenizável, este dano terá decorrido direta e imediatamente da negativa indevida de seu custeio pela ré.

Por fim, o (c) dano também se verifica no caso em comento, vez que o paciente só teve o procedimento autorizado graças a tutela provisória de urgência.
Ora, não é razoável que se repute essa negativa como mero aborrecimento, pois o demandante se viu impossibilitada de descobrir o melhor tratamento para o seu caso, por resistência injusta da requerida em autorizá-la, o que gera *angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa quanto à sua recuperação*.
Destaco que a paciente tinha, como é de conhecimento da ré, pensamentos suicidas que vieram a se efetivar com uma testativa de suicídio antes do teste deferido por este Juízo, de forma que a negativa gerou inquestionavelmente danos extrapatrimoniais, já que o tratamento mais eficiente poderia a vir evitar que ela atentasse contra a própria vida.
Vejamos julgado reconhecendo os danos morais em caso idêntico, o qual me filio:

> AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. **PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE. RECUSA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO**. I - O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. II - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. III - Na demanda, foi prescrito exame farmacogenético à autora, portadora de transtorno depressivo grave com ideação suicida, para melhor manejo farmacológico do seu quadro clínico, em razão da baixa resposta aos medicamentos já utilizados. IV - A recusa de cobertura pela Seguradora-ré foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. **V - A negativa de cobertura gerou ansiedade, angústia e estresse à autora, aptos a caracterizar o dano moral. VI - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença**. VII - Apelação desprovida.
> (TJDFT. APL. 07397101620208070001 - (0739710-16.2020.8.07.0001 - Res. 65 CNJ). Relatora: VERA ANDRIGHI. 6ª Turma Cível. Julg.: 23/06/2021)

De mais a mais, o caso em comento carece de "grande esforço dogmático" para a caracterização dos danos morais, uma vez que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça é uníssono ao estabelecer que esse tipo de negativa promovida por planos de saúde gera dano moral *in re ipsa*, senão vejamos:

> AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC)- DEMANDA POSTULANDO **INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO NA NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE** - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO RECLAMO DA CONSUMIDORA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL E ARBITRADA A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.
> 1. **A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral**, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. **Caracterização de dano moral in re ipsa**. Precedentes.

(...)
4. Agravo regimental desprovido.
(Processo: AgRg no AREsp 144028 SP 2012/0002890-0. Relator(a): Ministro MARCO BUZZI. Julgamento: 03/04/2014. Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA. Publicação: DJe 14/04/2014).

Ex positis, na esteira destes entendimentos, levando em conta também o caráter pedagógico da indenização por danos morais, entendo como devido a título de danos morais o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor da demandante.

DECISÃO:

Pelo exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado na inicial, e, por conseguinte:

a) Torno definitiva a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência de id. 159354393, e, por conseguinte, condeno a demandada a custear integralmente a realização do TESTE FARMACOGENÉTICO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM FAVOR DA AUTORA, MARCELE FRANCA PAIVA GOMES, CPF 110.313.504-03, SOB PENA DE BLOQUEIO DO IMPORTE FINANCEIRO REFERENTE AO CUSTO DO TRATAMENTO, POR MEIO DA FERRAMENTA SISBAJUD, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONFORME ARTIGO 497 DO CPC
b) Condeno a demandada, ainda, a reparar a demandante - a título de danos morais - no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente corrigidos monetariamente (Tabela ENCOGE) e acrescido de juros legais da data do arbitramento (sumula 362 – STJ).
c) Condeno, por fim, a demandada a restituir a demandante no valor das custas e taxas judiciais recolhidas para o ingresso da demanda.

Pelo que **EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO**, com base no artigo 487, inciso I, do CPC.

Arbitro os honorários a serem pagos pela demandada em favor dos advogados da demandante no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Condeno a demandada em custas processuais finais, caso existam valores pendentes de recolhimento em favor do TJPE.
Intimem-se as partes desta sentença.

Após o trânsito em julgado, determino que sejam tomadas todas as medidas legais para salvaguardar o interesse público no recolhimento das custas processuais finais, caso existentes, pela demandada, em favor do TJPE.

Cumpridas todas as determinações supra, arquive-se o processo.

P.R.I.

Recife, 12 de agosto de 2024.

LUZICLEIDE MARIA MUNIZ VASCONCELOS
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: MARCELO RUSSELL WANDERLEY
13/08/2024 11:05:50
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 178638213

24081311055031200000174321960

IMPRIMIR GERAR PDF